

Діабет і перименопауза

Що насправді змінюється в компенсації діабету 1 типу після 40, що допомагає і як домогтися, щоб вас почули лікарі.

Лена Філатова

Засновниця Школи діабету та онлайн-продуктів для здоров'я й велнесу.
23 роки життя з діабетом 1 типу

Що всередині

- Чому компенсація стала важчою і чому це не ваша провина
- 30+ ознак перименопаузи, включно з тими, про які ви не здогадуєтесь
- Двотижневий щоденник, який можна взяти на прийом
- Що сказати лікарю і шість запитань, які варто поставити
- Як отримати якісну допомогу NHS, якщо вас не слухають
- Чотири інструменти, які справді змінили ситуацію для мене
- Британські ресурси, де знайти більше інформації
- Джерела, правила та закони, на які можна послатися на прийомі в NHS, щоб отримати допомогу

Як користуватися цим воркбуком

Цей робочий зошит створено, щоб допомогти вам розпізнати ознаки перименопаузи, зібрати корисну інформацію та отримати якісну підтримку від вашого лікаря. Рекомендую частину сторінок роздрукувати й заповнити від руки, і саме заповнені сторінки роблять розмову з лікарем продуктивною. Ось кроки, які я рекомендую.

1 Позначте свої ознаки у першому розділі

Позначені пункти стануть вашим списком симптомів на прийомі.

2 Заповніть та роздрукуйте щоденники зі сторінок 15 та 16

Найкраще у двох різних фазах циклу, а не два спокійні тижні поспіль.

3 Заповніть сторінку підготовки до прийому

Випишіть три речі, які найбільше заважають вам жити, і одну конкретну цифру до кожної.

4 Візьміть роздруківки з собою

Папір на столі змінює розмову сильніше за будь-який опис словами. Разом із ним можна показати сторінку 25 з джерелами.

УВАГА! Цей воркбук містить освітні матеріали та не замінює консультації лікаря. Усе, що тут є, призначене для того, щоб ви прийшли на прийом підготовленою, а не щоб лікувати себе самостійно. Обов'язково консультуйтеся з лікарем перед тим, як приймати рішення щодо вашого здоров'я.

Нотатки

Вам не здається

Я живу з діабетом 1 типу з 2003 року і завжди непогано справлялась з викликами компенсації: складними домашніми стравами, фізичним рухом, їжею в подорожах, стресовими ситуаціями. Але ближче до 40 мої напрацьовані десятиліттями методи перестали працювати так само.

У 38 в мене з'явилися панічні атаки та дуже дивна алергічна реакція: кропив'янка по всьому тілу, яка виступала щодня, як по годиннику, у другій половині вечора. Я знала, що в моєму тілі відбуваються якісь системні зміни, але ні я, ні лікарі не могли зрозуміти, які саме. Усі аналізи були в нормі, я так само правильно харчувалась та регулярно займалась фізичною активністю.

У період між 39 та 41 роками я активно працювала над покращенням чутливості до інсуліну: додавала та змінювала фізичну активність, працювала над ментальним здоров'ям. Регулярно збирала статистику, аналізувала та коригувала свої дози, зверталась до лікарів з питаннями про те, що відбувається і як з цим впоратись. Але в них не було ніяких відповідей окрім «у вас все чудово».

У мої 42 додалися ще симптоми, які разом з нормальними аналізами неможливо було скоригувати. Усі лікарі запевняли, що в мене все добре, а про менопаузу думати зарано, оскільки цикл регулярний.

Але я зібрала підтвердження абсолютно неадекватної поведінки мого тіла, що було вже важко ігнорувати. Наприклад: зранку я роблю одну каву на соєвому молоці, це близько 4 г вуглеводів. Цукор підіймається до 18 ммоль/л.

У залі та сама історія: цукор стрімко росте під час тренування та після, і це справжня боротьба, щоб повернути його в межі. Силові тренування справді підіймають глюкозу, тож частина цього була очікуваною, до цього я готувалась. Неочікуваним було те, скільки часу тепер потрібно, щоб вона знизилася.

Це не провал вашої компенсації, і вам це не здається. Це біологія, яку медичний світ лише починає сприймати серйозно.

Коли гарні цифри коштують забагато

Я запитала свою діабетичну команду, що відбувається. Вони подивилися на показники й сказали: усе добре, ви занадто суворі до себе. Але я точно знала, чого коштували добрі цифри: набагато більше зусиль і набагато більше голоду, ніж роком раніше. У робочих поїздках я пропускала прийоми їжі, аби не ризикнути стрибком посеред конференції чи події. Будь-яка сильна емоція, добра чи погана, підіймала мене до 17–18 ммоль/л.

Я почала постійно скасовувати зустрічі з друзями, тому що очікування самої зустрічі підвищувало цукор, і я була вимушена залишатись вдома, щоб його нормалізувати.

Їсти стало настільки важко, що в мене виробився страх прийому їжі: кожен раз я тривожилась, що не зможу компенсувати абсолютно здорову точно розраховану страву. Я постійно ходила голодна.

Коли я знову підняла це питання з ендокринологом, він сказав, що вони не мають підготовки з жіночого здоров'я для цього періоду життя. Оскільки цикли залишалися регулярними, він сказав, що я не в перименопаузі й лікувати нічого. Треба просто продовжувати рахувати і витримувати паузу перед їжею.

Тоді я вирішила взятися за цього слона по шматочках. Я подзвонила своєму сімейному лікарю (GP) і спитала, чи можу я щось зробити для тих симптомів перименопаузи, які в мене є. Мені пощастило: перша ж лікарка, на яку я натрапила, виявилась спеціалісткою із замісної гормональної терапії (ЗГТ) і підтвердила, що всі мої симптоми є показаннями для призначення ЗГТ у такому віці. Я вперше відчула, що мене розуміють і я не зійшла з розуму. Я відчула себе нормальною.

Механізм, який мені ніхто не пояснив

Коли в перименопаузі естроген та прогестерон коливаються, чутливість до інсуліну змінюється разом із ними.² Ті самі страви, що раніше тримали цукор стабільним, тепер піднімають його значно вище, і глюкоза загалом росте легше. Місяць від місяця гормони виробляються нестабільно, тому один цикл усе працює нормально, а інший ні.³ Виявити аналізами такі стрибки важко.

Корекція доз зайняла певний час: у мене були дискусії з іншими місцевими лікарями з сімейної клініки, бо частина з них не мала знань з діабету і зв'язку чутливості до інсуліну в цей період з жіночими гормонами.

Прийнято рахувати, що якщо в жінки немає припливів та регулярний цикл, у неї ще немає перименопаузи. Це не так: міжнародні критерії стадій репродуктивного старіння (Stages of Reproductive Aging Workshop, STRAW+10) будуються на змінах циклу, а припливи взагалі не входять до діагностичних критеріїв і найчастіше з'являються пізніше.¹ Є багато інших маловідомих симптомів, у тому числі зміни чутливості до інсуліну.

У кінці кінців усе спрацювало, і я отримала свою замісну терапію.

У перший день, як я використала пластир з естрогеном і прогестероном, моя чутливість до інсуліну повернулась протягом декількох годин. Того дня я лягла спати о восьмій вечора та проспала всю ніч, не прокидаючись, після чого зрозуміла, що не спала настільки добре декілька років.

Тому мій воркбук для всіх жінок з діабетом та їхніх рідних і друзів, хто хоче підтримати їх у цей період. Це те, що я хотіла б отримати та дізнатись у свої 38.

Розгорнута версія цієї історії з посиланнями на дослідження: [Перименопауза та діабет: що насправді відбувається з вашим цукром у крові](#)

Ознаки, що річ у гормонах, а не у ваших зусиллях

Жодна з них сама по собі не є діагнозом. Разом, і особливо якщо вони з'явилися за останній рік-два ближче до 40 років або після, їх варто винести на прийом. Позначте те, що впізнаєте: це знадобиться на сторінці 18.

ЦУКОР І КОМПЕНСАЦІЯ ДІАБЕТУ

☐ **Дози, що працювали роками, тепер недостатні або періодично недостатні**

Без додаткових причин на кшталт більших порцій, меншого руху, стресу чи хвороби.

☐ **Та сама їжа й активність поводяться по-різному з місяця в місяць**

Однаковий сніданок один цикл керований, а наступний ні.

☐ **Емоції впливають на глюкозу сильніше, ніж колись**

Новина, добра чи погана, підіймає вас на 3–4 ммоль/л, і повертається ви повільно.

☐ **Ви працюєте набагато більше заради того самого результату**

Цифри ще гарні, але ціна цих цифр помітно виросла.

☐ **Глюкоза довше повертається в межі після тренування**

Підйом під час силових очікувань, а от його тривалість тепер інша.

☐ **Нічні та ранкові цифри повзуть угору**

Ранкова боротьба починається раніше й потребує більших корекцій.

ЦИКЛ І РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА

☐ **Цикл став коротшим**

Місячні приходять кожні 21–24 дні замість звичних 28.

☐ **Цикл став довшим**

Розтягується понад 35 днів або пропускається місяць-другий.

☐ **Рясніші кровотечі (менорагія)**

Великі згустки, протікання, прокладка чи тампон не витримують звичного часу.

☐ **Мізерні кровотечі**

Ледь помітне мазання, якому майже не потрібен засіб гігієни.

☐ **Непередбачувані дати початку**

Закономірність зникла, планувати неможливо.

☐ **Тривалі кровотечі понад сім днів поспіль**

Довше, ніж було нормою саме для вас.

☐ **Мазання між місячними**

Кров або коричневі виділення посеред циклу.

☐ **Сильні спазми (дисменорея)**

Новий або помітно сильніший тазовий біль.

☐ **Посилився передменструальний синдром (ПМС)**

Нагрубання грудей, здуття живота, втома, дратівливість і болі стали помітно сильнішими, ніж раніше.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ЦИКЛ І РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА (ПРОДОВЖЕННЯ)

- ☐ **«Фантомні місячні»**
Спазми, здуття й усі симптоми ПМС є, а кровотечі немає.
- ☐ **Сухість піхви**
Слизова стоншується й пересихає через низький естроген.
- ☐ **Атрофія піхви**
Втрата еластичності тканин, відчуття, що піхва стала вужчою або коротшою.
- ☐ **Біль під час сексу (диспареунія)**
Печіння, різь або відчуття надриву. Це піддається лікуванню, зокрема місцевими формами естрогену.
- ☐ **Свербіж і печіння зовнішніх статевих органів**
Постійне подразнення вульви без інфекції.

ПРИПЛИВИ Й ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

- ☐ **Класичні припливи**
Раптова хвиля жару, що розливається обличчям і грудьми.
- ☐ **Нічна пітливість**
Настільки сильна, що доводиться міняти одяг або білизну.
- ☐ **Холодна хвиля одразу після припливу**
Озноб до цокотіння зубами.
- ☐ **Денний озноб без причини**
Вам крижано холодно в теплій кімнаті.
- ☐ **Раптова пітливість без спеки й навантаження**
Піт ллється тоді, коли для цього немає жодного приводу.
- ☐ **Почервоніння обличчя, шиї та грудей**
Видима пляміста червоність, схожа на рум'янець.
- ☐ **Непереносимість спеки**
Тепла погода або гаряча ванна стали нестерпними.
- ☐ **Липка шкіра**
Постійне відчуття холодної вологої шкіри.

НЕВРОЛОГІЯ ТА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ

- ☐ **[«Туман» у голові](#)**
Загальна відчуття хмарності й сповільненого мислення.
- ☐ **Провали короткочасної пам'яті**
Забуваєте, навіщо зайшли в кімнату, губите ключі.
- ☐ **Важко підібрати слово**
Звичайні слова не згадуються, ви зупиняєтесь посеред речення.
- ☐ **Погіршилась концентрація**
Важко зосередитись на читанні, роботі чи розмові.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

НЕВРОЛОГІЯ ТА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)

- ☐ **Просторова дезорієнтація**
Зачіпаєте одвірки, впускаєте предмети, стали незграбнішою.
- ☐ **Запаморочення**
Легкість у голові, відчуття нестійкості або короткі напади вертиго.
- ☐ **Шум у вухах**
Дзвін, гудіння або шипіння в одному чи обох вухах.
- ☐ **Гормональні мігрені**
Сильний пульсуючий біль, прив'язаний до падіння естрогену в циклі.
- ☐ **Головний біль напруження**
Постійний тиск у лобі та скронях.
- ☐ **Сенсорне перевантаження**
Гучні звуки, яскраве світло чи натовп швидко виснажують.
- ☐ **Фантомні запахи**
Найчастіше диму або чогось незрозуміло неприємного, чого поруч немає.
- ☐ **Формікація**
Відчуття, ніби по шкірі або під нею повзають комахи.
- ☐ **Відчуття «удару струмом»**
Короткий різкий запід шкірою, часто за секунду до припливу.
- ☐ **Поколювання в кінцівках (парестезія)**
Мурашки в пальцях рук і ніг, долонях, ступнях.
- ☐ **Оніміння ділянок шкіри**
Тимчасова втрата чутливості на невеликих ділянках.

НАСТРІЙ І ПСИХІКА

- ☐ **Раптова дратівливість**
Зриваєтесь через дрібниці, терпіння закінчується миттєво.
- ☐ **Спалахи гніву без приводу**
Лють, яку важко контролювати.
- ☐ **Генералізована тривожність**
Постійне фонове відчуття тривоги через звичайні справи.
- ☐ **Панічні атаки**
Раптові напади жаху з фізичними симптомами.
- ☐ **Тривога про здоров'я**
Нова або нав'язлива думка, що ви серйозно хворі.
- ☐ **Знижений настрій**
Стійкий сум, сплюснені емоції, відчуття порожнечі.
- ☐ **Депресія**
Загострення наявної або перший в житті депресивний епізод.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

НАСТРІЙ І ПСИХІКА (ПРОДОВЖЕННЯ)

- ☐ **Раптові сльози**
Плачете несподівано, без очевидного приводу.
- ☐ **Втрата впевненості в собі**
Раптом сумніваєтесь у своїх професійних навичках, зовнішності, рішеннях.
- ☐ **Соціальна ізоляція**
Хочеться відгородитись від друзів, родини й будь-яких зустрічей.
- ☐ **Різкі перепади настрою**
Радість, гнів і сум змінюють одне одного за кілька годин.
- ☐ **Відчуття, що станеться щось погане**
Безпричинне передчуття біди.
- ☐ **Втрата задоволення (ангедонія)**
Улюблені заняття більше не тішать.
- ☐ **Деперсоналізація**
Відчуття відстороненості від власного тіла, ніби спостерігаєте за собою збоку.

СОН

- ☐ **Важко заснути**
Лежите годинами, а сон не приходить.
- ☐ **Прокидаєтесь о 2–3 ночі й не можете заснути**
Найтиповіший гормональний патерн порушення сну.
- ☐ **Раннє пробудження**
Прокидаєтесь задовго до будильника бадьорою і при цьому виснаженою.
- ☐ **Сон не відновлює сили**
Прокидаєтесь такою ж втомленою, як лягали.
- ☐ **Нестерпний апетит уночі**
Важко заснути, поки не поїсте.
- ☐ **Надто яскраві сни**
Незвично інтенсивні, дивні або емоційно виснажливі.
- ☐ **Часті кошмари**
Настільки тривожні, що розривають сон.
- ☐ **Хропіння або зупинки дихання уві сні (апное)**
З'явилося уперше або помітно посилилось.
- ☐ **Синдром неспокійних ніг (СНН)**
Непереборне бажання рухати ногами, щойно вилягли. Зв'язок із менопаузою описаний, але суперечливий: більшість жінок із СНН відзначають погіршення після менопаузи, хоча гормональна терапія допомагає не завжди.

М'ЯЗИ, СУГЛОБИ Й КІСТКИ

- ☐ **Ранкова скутість суглобів**
Коліна, стегна чи пальці «іржаві» після сну.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

М'ЯЗИ, СУГЛОБИ Й КІСТКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

- ☐ **Глибокий біль у суглобах (артралгія)**
Ніє і пульсує, хоча артрити немає.
- ☐ **Біль у м'язах**
Розлита ломота, схожа на грип.
- ☐ **М'язова слабкість**
Важче нести покупки чи відкрити банку.
- ☐ **Заморожене плече**
Сильна скутість і біль у плечовому суглобі. Один із найтипівіших і найменш відомих симптомів.
- ☐ **Підошовний фасціїт**
Різкий колючий біль у п'яті, найгірше з ранку.
- ☐ **Тендиніт**
Запалення сухожиль, особливо зап'ястків та ахілла.
- ☐ **Біль у попереку**
Новий або помітно сильніший.
- ☐ **Зниження щільності кісток (остеопенія)**
Кістка стоншується швидше в міру падіння естрогену. Не відчувається, але виявляється денситометрією.

СЕРЦЕ Й СУДИНИ

- ☐ **Серцебиття**
Раптове відчуття, що серце калатає або тріпоче.
- ☐ **Відчуття пропущеного удару (екстрасистоли)**
Серце ніби завмирає на мить.
- ☐ **Стрибки артеріального тиску**
Різкі коливання або загальне підвищення тиску в спокої.
- ☐ **Запаморочення при різкому вставанні**
Постуральна гіпотензія, і вона не пов'язана з низьким цукром.
- ☐ **Холодні руки й ноги**
Погіршення периферичного кровообігу.
- ☐ **Легко з'являються синці**
Судини стають крихкішими, синці виникають без явних ударів.
- ☐ **Набряки щиколоток**
Затримка рідини й гірший відтік.

ШКІРА, ВОЛОССЯ Й НІГТІ

- ☐ **Сильна сухість шкіри**
Шорстка, лущиться, потребує щільного крему.
- ☐ **Втрата пружності шкіри**
Шкіра стоншується, обвисає, зморшки з'являються швидше, ніж очікували.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ШКІРА, ВОЛОССЯ Й НІГТІ (ПРОДОВЖЕННЯ)

- ☐ **Гормональне акне**
Глибокі болючі висипання вздовж лінії щелепи й на підборідді.
- ☐ **Свербіж шкіри без висипу**
Свербить усе тіло, зокрема у вухах і на лопатках, а дивитись немає на що.
- ☐ **Порідіння волосся на голові**
Дифузна втрата або проділ, що поступово розширюється.
- ☐ **Ламкі нігті**
Розшаровуються, тріскають, ламаються від дрібниць.
- ☐ **Поздовжні борозни на нігтях**
Виражені вертикальні лінії, яких раніше не було.
- ☐ **Волосся на обличчі (гірсутизм)**
Жорсткі темні волоски на підборідді, над губою, вздовж щелепи.
- ☐ **Втрата волосся на тілі**
Рідшає волосся на лобку, під пахвами, на ногах.
- ☐ **Змінився запах тіла**
Той самий дезодорант перестав працювати так, як раніше.
- ☐ **Раптова чутливість шкіри та нові алергії**
Кропив'янка чи реакція на тканини, мило, сонце, на які раніше реакції не було.

ТРАВЛЕННЯ Й ОБМІН РЕЧОВИН

- ☐ **Жир перерозподіляється на живіт**
Та сама цифра на вагах, інша форма, інший одяг.
- ☐ **Вага повзе вгору без змін у харчуванні**
Звичний режим перестав утримувати вагу.
- ☐ **Здуття живота**
До вечора одяг стає тісним.
- ☐ **Нові харчові непереносимості**
Молочне, глютен чи гостре раптом дають розлад.
- ☐ **Непереносимість гістаміну**
Вино, витриманий сир, учорашня їжа дають висип, закладеність носа чи головний біль.
- ☐ **Нудота**
М'які, але настирливі хвилі, схожі на ранкову нудоту.
- ☐ **Закрепи**
Кишківник став помітно повільнішим.
- ☐ **Діарея або синдром подразненого кишечника (СПК)**
Раптові позиви, рідкі випорожнення, спазми після їжі.
- ☐ **Печія та кислотний рефлюкс**
Кислота підіймається вгору частіше, ніж раніше.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ТРАВЛЕННЯ Й ОБМІН РЕЧОВИН (ПРОДОВЖЕННЯ)

- ☐ **Надмірне газоутворення**
Помітно більше й болючіше, ніж було нормою.
- ☐ **Змінилось відчуття смаку**
Їжа гірчить, віддає металом або втратила звичний смак.

СЕЧОВИЙ МІХУР

- ☐ **Часте сечовипускання вдень**
У туалет потрібно значно частіше, ніж раніше.
- ☐ **Нічні походи в туалет (ніктурія)**
Прокидаєтесь по кілька разів за ніч саме через це.
- ☐ **Стресове нетримання**
Підтікання при кашлі, чханні, сміху чи тренуванні.
- ☐ **Ургентне нетримання**
Раптовий непереборний позив, який не встигаєте стримати.
- ☐ **Рецидивні інфекції сечових шляхів**
Часті болючі цистити через стоншення слизової.
- ☐ **Біль у сечовому міхурі (інтерстиційний цистит)**
Печіння під час сечовипускання без жодної інфекції в аналізах.
- ☐ **Слабкість м'язів тазового дна**
Відчуття тяжкості й тиску вниз живота.

РОТ, ОЧІ, ГРУДИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН

- ☐ **Синдром печіння в роті**
Пекучий біль на язичку, піднебінні або губах.
- ☐ **Кровоточивість ясен**
Запалення й кров під час чищення зубів. Стоматолог може помітити це раніше за вас.
- ☐ **Сухість у роті**
Слини бракує, важче ковтати й говорити.
- ☐ **Сухість очей**
Відчуття піску, печіння, чутливість до світла, втома очей.
- ☐ **Зміни зору**
Розмитість або несподівана зміна діоптрій.
- ☐ **Болючість грудей**
Глибокий пульсуючий або простріловий біль в одній чи обох грудях.
- ☐ **Зміна форми й розміру грудей**
Втрата залозистої тканини змінює обриси.
- ☐ **Зміни лібідо**
Різке падіння або, навпаки, раптовий тимчасовий сплеск.

☐ Хронічна втома

Повне фізичне виснаження, яке не минає навіть після доброго сну.

Скільки ознак ви позначили?

Впишіть число сюди і перенесіть його на сторінку підготовки до прийому. Три та більше ознак, які з'явились за останній рік-два, це вже привід для розмови, а не для очікування.

Дві речі, які кажуть часто і які не відповідають дійсності: що регулярні місячні виключають перименопаузу, і що без припливів вона ще не почалася. Ані те, ані інше не правда.¹ У мене весь цей час були регулярні цикли й жодного припливу.

Нотатки

Окремо про настрій. Якщо знижений настрій, тривога чи відчуття відстороненості від себе тримаються тижнями або заважають жити, не чекайте наступного планового прийому. Це варто винести до лікаря окремо й швидше, незалежно від того, гормональна це причина чи ні.

Що ще ви помітили за собою, чого немає у списку

Ваш двотижневий щоденник

Два тижні структурованих даних змінять прийом сильніше, ніж будь-який опис словами.

Роздрукуйте цю сторінку й заповнюйте від руки: мета не в ідеальних записах, а в закономірності, яку лікар побачить за десять секунд.

День	День циклу	Глюкоза натще	Добова доза інсуліну	Час у межах %	Сон (год / якість)	Найпомітніший симптом
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Зробіть контраст помітним. Якщо вдасться, ведіть щоденник у двох різних фазах циклу, а не два спокійні тижні поспіль. Саме різниця між тижнями і є доказом: два однакові тижні скажуть команді значно менше.

Щоденник симптомів і підсумок двох тижнів

Цифри показують закономірність, а симптоми показують ціну. Впишіть у ліву колонку ті симптоми, які турбують саме вас, і щодня позначайте ті, що були. У кінці двох тижнів порахуйте, скільки днів кожен з них займав.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Підсумок двох тижнів

Найвища добова доза інсуліну

.....

Найнижча добова доза інсуліну

.....

Різниця між ними

.....

Середній час у межах, тиждень 1

.....

Середній час у межах, тиждень 2

.....

День циклу, коли було найважче

.....

Ця різниця і є вашим головним аргументом. Якщо добова доза відрізняється між тижнями більш ніж на 15–20 відсотків за тієї самої їжі й тієї самої активності, це та цифра, з якої варто починати розмову на наступній сторінці.

Нотатки

Що сказати на прийомі

Мене достатньо разів відправляли додому з формулюванням «у вас все чудово» та «ви чудово виглядаєте», тобто з позицією, що це все мені здається. Тому треба не тільки збирати чітку аналітику, а й правильно формулювати свою стурбованість і той ефект, який симптоми справляють на ваше повсякденне життя. Лікарі реагують на динаміку й конкретику: ті самі факти, інше формулювання.

ЗАМІСТЬ

«Останнім часом цукри якісь дивні.»

СПРОБУЙТЕ

«За останні півроку моя добова доза інсуліну зросла з 32 до 45 одиниць за тієї самої їжі й тих самих тренувань. Ось щоденник і аналітика онлайн.»

ЗАМІСТЬ

«Мені здається, у мене перименопауза?»

СПРОБУЙТЕ

«Я фіксую циклічну закономірність в інсулінорезистентності та список симптомів, які я записала в щоденнику. Хочу обговорити, чи не сприяють цьому гормональні зміни.»

Якщо вас не слухають

Не здавайтесь, продовжуйте збирати інформацію та комунікувати своє занепокоєння. Якщо треба, просіть направлення до спеціаліста із ЗГТ у межах вашої практики.

І користуйтеся правилами, які вже існують. Найкорисніше з них тут: в Англії з вересня 2025 року діє Jess's Rule, за яким при третьому зверненні з тими самими симптомами команда сімейних лікарів має переглянути діагноз, а не повторити попередній висновок.⁷ Повний перелік правил, на які можна послатися, зібраний на сторінці 20.

ФОРМУЛЮВАННЯ, ЯКЕ ПРАЦЮЄ:

«Це мій третій візит із тими самими симптомами. Я хотіла б, щоб ми переглянули діагноз у межах Jess's Rule, і щоб у картці було зафіксовано, чи розглядались гормональні зміни як чинник.»

Сторінка підготовки до прийому

Заповніть це напередодні й візьміть із собою разом із щоденником. Десять хвилин тут коштують більше, ніж година пояснень у кабінеті.

Скарги, з якими я сьогодні прийшла

Дуже коротко, одним реченням: симптоми, які турбують найбільше.

Наскільки це критично в повсякденному житті

Наприклад, чи обмежують симптоми виконання робочих обов'язків, чи впливають на щоденну рутину.

Що я вже пробувала робити, щоб покращити ситуацію

Чого я хочу від цього прийому

Одним реченням: пройти обстеження, отримати направлення до вузького спеціаліста, отримати інформаційні ресурси тощо.

Наскільки швидко мені потрібно змінити ситуацію

Чи потрібне термінове рішення, чи симптоми не заважають сильно і можна зачекати.

Якщо вам кажуть, що перименопаузи бути не може, бо цикли регулярні та немає припливів, ввічливо попросіть внести це обґрунтування у ваші записи або попросіть другу думку. Регулярні цикли й відсутність припливів не завадили мені врешті отримати ЗГТ: просто знадобився спеціаліст, готовий слухати.

Що сказали на прийомі

Заповнюйте просто в кабінеті або одразу після. Якщо на запитання не відповіли, поставте прочерк: це теж інформація, і саме вона знадобиться на наступному візиті.

- 1 Чи має хтось у цій команді підготовку з жіночого здоров'я після 40?

- 2 Чи може падіння естрогену пояснювати зростання моєї потреби в інсуліні?

- 3 Що саме вам треба побачити від мене, щоб розглянути гормональні зміни як чинник?

- 4 Чи є причина не направляти мене до спеціаліста з перименопаузи?

- 5 Як відрізнити симптоми перименопаузи від симптомів гіпоглікемії?

- 6 Чи можемо ми домовитися про дату перегляду, а не залишати це відкритим?

Про що домовились

Дата перегляду _____

Направлення: до кого і коли _____

Що я маю зробити до наступного разу _____

Що записали в картку про гормональні зміни _____

Нотатки

Як отримати якісну допомогу NHS, якщо вас не слухають

Більшість жінок не отримують допомогу не тому, що її не існує, а тому, що не знають, як вона називається. Ось правила Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS), на які можна послатися вголос, і кожне з них перевіряється за одну хвилину в інтернеті.

Jess's Rule: три звернення і переглядаємо діагноз

Якщо ви звертаєтесь утретє з тими самими або наростаючими симптомами, команда сімейних лікарів має переглянути діагноз, а не повторити попередній висновок: подумати ще раз, порадитись із колегою і, якщо потрібно, направити далі. Це ініціатива Департаменту охорони здоров'я і соціального забезпечення (DHSC) та NHS England за підтримки Королівського коледжу сімейних лікарів (RCGP), чинна з вересня 2025 року.⁷ Це не закон і не автоматичне право на обстеження, але це офіційна вимога до практик.

Скажіть так: «Це мій третій візит із тими самими симптомами. Прошу переглянути діагноз у межах Jess's Rule.»

Після 45 діагноз ставлять за симптомами, а не за аналізами

Настанова Національного інституту здоров'я та досконалості медичної допомоги (NICE) NG23 прямо каже: не використовуйте лабораторні аналізи, щоб визначити перименопаузу чи менопаузу в людей від 45 років. У 40–45 років аналіз фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) можна розглянути, якщо є симптоми разом зі змінами циклу. Тобто «у вас нормальні аналізи, отже це не перименопауза» суперечить настанові.⁹

Скажіть так: «Наскільки я розумію NICE NG23, у моєму віці діагноз клінічний. Чи можемо ми виходити з симптомів?»

Право обрати, до кого вас направлять

В Англії при першому направленні до лікаря-консультанта ви маєте законне право обрати будь-якого клінічно придатного постачальника послуг і навіть конкретну команду під керівництвом названого консультанта. Це і є той механізм, яким користуються, щоб потрапити саме до менопаузальної клініки, а не туди, куди ближче.¹⁰

Скажіть так: «Я хочу скористатися правом вибору і бути направленою саме до менопаузальної клініки. Ось яка мене цікавить.»

Де саме це діє. Jess's Rule і право вибору стосуються Англії. Настанови NICE діють в Англії та Уельсі, а Шотландія й Північна Ірландія мають власні еквіваленти. Якщо ви не в Англії, правило те саме, а назва інша: спитайте у практиці, як це називається у вас.

Як отримати якісну допомогу NHS, продовження

Ваша картка належить вам

За Data Protection Act 2018 і UK GDPR ви маєте законне право побачити, що саме про вас записано. Найшвидше через застосунок NHS App, а якщо там неповно, подайте письмовий запит на доступ до даних (Subject Access Request, SAR) у практику. Це найкращий спосіб перевірити, чи справді зафіксували ваші скарги і чи розглядались гормональні зміни.

Читайте записи після кожного прийому, а не раз на рік.

Друга думка: просити можна, гарантії немає

Права на другу думку в законі немає, але просити ви можете завжди, і практики зазвичай ідуть назустріч. Якщо відмовляють, попросіть, щоб відмову та її обґрунтування внесли в картку. Це різко змінює тон розмови.

Якщо не допомогло, зверніться до служби підтримки пацієнтів (Patient Advice and Liaison Service, PALS), потім подайте офіційну скаргу, і лише після цього до Омбудсмана парламенту та служби охорони здоров'я (PHSO).

ЗГТ за фіксовану річну плату

Сертифікат передоплати за рецептами на ЗГТ (HRT Prescription Prepayment Certificate, HRT PPC) коштує 19,80 фунта одноразово й покриває необмежену кількість певних препаратів ЗГТ протягом 12 місяців, тоді як один пункт рецепта коштує 9,90 фунта. Тобто якщо ви отримуєте ЗГТ тричі на рік або частіше, сертифікат себе окупає.¹¹

Перевірте, що ваш препарат входить до списку покриття, перш ніж купувати.

Ваш щорічний діабетичний огляд це теж важіль

Diabetes UK формулює 15 перевірок і послуг, на які ви маєте право щороку. Серед них окремо є емоційна й психологічна підтримка та можливість обговорити сексуальні проблеми. Це законна підстава внести жіноче здоров'я в порядок денний щорічного огляду, а не чекати окремого прийому.¹²

Скажіть так: «Я хочу, щоб цього року в мій річний огляд увійшла й розмова про гормональні зміни.»

Одне речення, яке варто вивчити напам'ять: «Будь ласка, зафіксуйте в картці, що я підняла це питання і яке рішення було прийняте.» Воно нічого не коштує, звучить ввічливо і працює краще за будь-яку суперечку.

Нотатки

Чотири інструменти, які справді спрацювали

Це те, що спрацювало для мене, у порядку значущості. Кожне рішення щодо вашої компенсації належить вам і вашому лікарю. Моє завдання тут у тому, щоб ви знали, що існує і про що питати.

1 Розмова про ЗГТ

Найбільший важіль, який я знайшла. Моя сімейна лікарка спочатку не була переконана, що гормони впливають на чутливість до інсуліну, хоча я вважала це настільки фундаментальним, що знає будь-який медик: усі гормони впливають одне на одного. Це не порожнє припущення: вплив гормональної терапії на глікемію саме у жінок з діабетом уже зібрано в систематичний огляд, на який можна послатися.⁴ Знадобився час, дискусії і, звісно, спеціалістка, яка розуміється на цьому. Але для призначення вам обов'язково потрібен лікар, не призначайте гормони самі собі. Щодо БАДів моя думка така: препарати, які вільно продаються (трави, настоянки, гомеопатія), мають приблизно таку ж ефективність у компенсації жіночих гормонів, як і інсуліну.

Почніть звідси: просіть направлення, а не рецепт. Регулярні цикли не є перешкодою. [Що відбувається з призначеннями ЗГТ](#)

2 Силові тренування двічі-тричі на тиждень

Найнадійніший немедикаментозний інструмент: м'язи покращують те, як тіло працює з глюкозою, захищають кістки та стабілізують енергію краще за будь-яку окрему добавку.⁵ Це доведений спосіб зберегти м'язи та кісткову тканину у жінок, які вступають у перименопаузу. Якщо ви ніколи не займались силовими вправами, варто почати якомога скоріше. Живіть із парадоксом: під час силових навантажень глюкоза часто росте, і під час, і одразу після тренування, тоді як ефект за кілька тижнів впевнено протилежний. Цукри стають стабільнішими, і з ними легше впоратись, якщо займатись регулярно.

Почніть звідси: два заняття на тиждень, базові вправи, і оцінюйте результат по місяцю, а не по тренуванню.

Нотатки

Чотири інструменти, продовження

3

Більше білка, клітковини та ніяких голодувань

У цей час на фоні коливань естрогену жир на животі «пакує» кортизол. Голодування, стреси та стрибки цукру й інсуліну тільки допомагають цьому процесу. Тому відмовтесь від жорстких дієт та заборон, які можуть погіршити симптоми перименопаузи та сприяти епізодичним зривам на солодке й калорійне. Колаген та м'язи починають прискорено втрачатись, тому так важливо вживати достатньо білка. Обов'язково враховуйте рекомендації вашого лікаря щодо кількості білка, але зверніть увагу на нові дослідження і спитайте, чи варто ці рекомендації переглянути.

Якщо немає бажання або часу їсти, я збиваю протейн з овочами та ягодами й додаю лляну мукку. Такий коктейль і смакує приємно, і насичує, і цукор підвищує дуже повільно. [Скільки білка насправді потрібно після 40](#)

4

Сон і стрес, найдешевший важіль, який зникає першим

Перименопауза руйнує сон, поганий сон погіршує компенсацію, а висока глюкоза руйнує спокій і сон та підвищує кортизол. У жінок навіть помірне недосипання протягом кількох тижнів знижує чутливість до інсуліну незалежно від змін ваги,⁶ а в жінок у постменопаузі той самий ефект видно вже після чотирьох ночей.⁸ Це замкнене коло, і саме про нього зазвичай ніхто не питає, тож підніміть це питання самі. З порушеним сном, болем у суглобах, апатією і стрибками цукру навіть тренуватися стає важче. Я це теж помітила. Але просто так почати гарно спати може не вийти: віднесіться до цього симптому серйозно та вимагайте рішення.

Почніть звідси: записуйте сон поруч із глюкозою на сторінці 15, щоб зв'язок став видимим, а не теоретичним.

Усі ці інструменти працюють краще в комплексі. Дайте певний час, близько 6–12 місяців, на адаптацію вашого тіла, спостерігайте за змінами і залишайтеся у контакті з лікарем на випадок, якщо щось доведеться скоригувати.

Нотатки

Британські ресурси, де знайти більше інформації

Якщо шукаєте, з чого почати, ці організації мають найрелевантнішу інформацію саме для жінок із діабетом, які проходять перименопаузу, і ось що варто просити в NHS.

Diabetes UK

Найбільша діабетична благодійна організація Британії: є гаряча лінія та добре модерований форум підтримки, де саме це поєднання обговорюють часто. Корисно, коли треба переконатися, що ви не єдина.

diabetes.org.uk

Women's Health Concern (WHC) і British Menopause Society (BMS)

WHC це пацієнтський напрям BMS, професійного товариства з менопаузи. Саме їхні інформаційні листи я б брала на прийом: написані лікарями, з посиланнями, і їх важко відмахнути.

womens-health-concern.org · thebms.org.uk

Jess's Rule (NHS England)

Офіційна сторінка ініціативи «три звернення і переглядаємо діагноз». Якщо ви йдете втретє з тими самими симптомами, варто мати її під рукою.

[england.nhs.uk · Jess's Rule](https://england.nhs.uk/Jess's Rule)

NICE NG23 і NHSBSA

Сама настанова щодо менопаузи, на яку можна послатися на прийомі, і сторінка, де купують сертифікат HRT PPC за 19,80 фунта на рік. Обидві офіційні, обидві безкоштовні для читання.

nice.org.uk/guidance/ng23

Читати далі: розгорнута версія моєї історії з посиланнями на дослідження у блозі:

lenafilatova.co.uk/ua/blog/perimenopause-diabetes-blood-sugar

Нотатки

Джерела, правила та закони, на які можна посплатися

Номери відповідають позначкам у тексті, назви клікабельні. Не роздруковуйте все: оберіть одну-дві роботи, найближчі до вашої ситуації, і назвіть їх на прийомі разом зі своїм щоденником.

- 1 [Harlow SD та ін. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop +10 \(STRAW+10\). Menopause, 2012.](#)
Міжнародні критерії стадій перименопаузи. Будуються на змінах циклу; припливи не входять до діагностичних критеріїв.
- 2 [Menopause management in women with type 1 diabetes mellitus: a narrative review. Endocrine Connections, 2026. doi.org/10.1530/EC-25-0486](#)
Огляд того, що відомо і що ні про менопаузу при діабеті 1 типу: падіння естрадіолу, зниження чутливості до інсуліну, зміни складу тіла.
- 3 [Menstrual Cycle, Glucose Control and Insulin Sensitivity in Type 1 Diabetes: A Systematic Review. 2023. PMC9962060](#)
Систематичний огляд коливань глікемії та потреби в інсуліні протягом циклу при діабеті 1 типу.
- 4 [Effect of Postmenopausal Hormone Therapy on Glucose Regulation in Women With Type 1 or Type 2 Diabetes: систематичний огляд і метааналіз. Diabetes Care, 2023;46\(10\):1866.](#)
Що відомо про вплив гормональної терапії на глікемію саме у жінок з діабетом.
- 5 [Effect of combined aerobic exercise and resistance training on postmenopausal women with type 2 diabetes: систематичний огляд і метааналіз. Gynecological Endocrinology, 2025.](#)
Комбіноване аеробне й силове навантаження покращило індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR). Дослідження стосується діабету 2 типу, прямих даних по 1 типу поки бракує.
- 6 [Zuraikat FM та ін. Chronic Insufficient Sleep in Women Impairs Insulin Sensitivity Independent of Adiposity Changes. Diabetes Care, 2024;47\(1\):117.](#)
Скорочення сну на півтори години на добу протягом шести тижнів знизило чутливість до інсуліну у жінок незалежно від змін ваги.
- 7 [NHS England. Jess's Rule: Three strikes and we rethink. Опубліковано 23.09.2025, оновлено 14.05.2026.](#)
Ініціатива DHSC і NHS England за підтримки RCGP: переглядати діагноз після третього звернення з тими самими симптомами.
- 8 [Effect of sleep restriction on insulin sensitivity and energy metabolism in post-menopausal women: рандомізоване перехресне дослідження. 2023. PMC10191900](#)
Чотири ночі обмеженого сну знизили чутливість до інсуліну у жінок у постменопаузі.
- 9 [NICE. Menopause: identification and management. NG23. Оновлено в листопаді 2024. nice.org.uk/guidance/ng23](#)
Після 45 років діагноз клінічний, лабораторні аналізи для визначення перименопаузи не використовують. У 40–45 можна розглянути ФСГ за наявності симптомів і змін циклу.
- 10 [NHS England. Patient choice guidance. england.nhs.uk](#)
Законне право обрати постачальника послуг і команду названого консультанта при першому направленні на консультацію в Англії.
- 11 [NHSBSA. NHS Hormone Replacement Therapy Prescription Prepayment Certificate \(HRT PPC\). nhsbsa.nhs.uk](#)
Сертифікат за 19,80 фунта покриває певні препарати ЗГТ на 12 місяців; один пункт рецепта коштує 9,90 фунта.
- 12 [Diabetes UK. 15 Healthcare Essentials. diabetes.org.uk](#)
Перелік перевірок і послуг, на які людина з діабетом має право щороку, включно з емоційною підтримкою.

Про Лену

Я живу з діабетом 1 типу вже 23 роки й пишу про жіноче здоров'я після 40 для тих, кому потрібні докази, а не заспокоєння. Маю досвід читання наукових статей і написання новин про здоров'я та фітнес, тож коли я не змогла знайти відповідей про діабет у перименопаузі, я почала відкриту розмову замість того, щоб чекати на неї.

Я не лікарка. Я та, хто пройшла ці прийоми, перечитала дослідження й з'ясувала, які запитання дають відповіді. Мені хочеться, щоб на наступний прийом ви прийшли підготовленішою, ніж свого часу прийшла я.

Тепер слово вам

Цей воркбук прийшов вам на пошту. Просто натисніть «відповісти» й напишіть, які з ознак ви впізнали. Я читаю кожен лист, і саме вони визначають, про що я пишу далі.

lenafilatova.co.uk

Цей воркбук має освітній характер і відображає мій особистий досвід та прочитання досліджень. Він не є медичною порадою й не замінює консультації кваліфікованого лікаря. Не змінюйте інсулін, ліки чи гормональну терапію на підставі написаного тут: кожне рішення щодо вашої компенсації слід приймати разом із вашим лікарем або діабетичною командою. © 2026 Лена Філатова · lenafilatova.co.uk